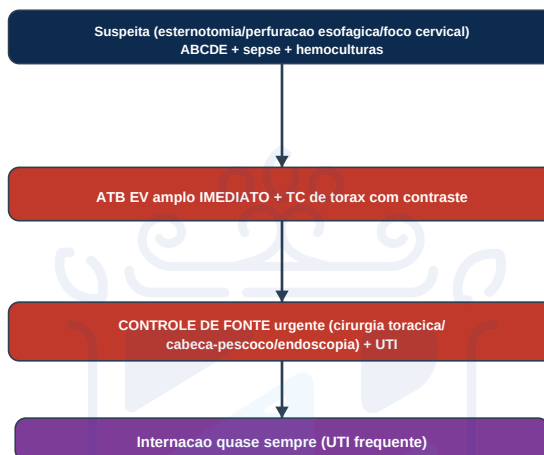


MEDIASTINITE AGUDA — ATB + CONTROLE DE FONTE

FLUXOGRAMA — EMERGÊNCIA SÉPTICA

MEDIASTINITE — TRATAR COMO SEPSE + DRENAR



DEFINIÇÃO E ETIOLOGIAS

INFECÇÃO DO MEDIASTINO

- Infecção/inflamação aguda do mediastino — quase sempre exige ATB EV + drenagem/cirurgia; alta mortalidade
- PÓS-ESTERNOTOMIA (cirurgia cardíaca): 7-30 dias de pós-op, febre, dor esternal, secreção na ferida, 'esterno instável'/clique
- PERFURAÇÃO ESOFÁGICA (endoscopia, corpo estranho, IOT difícil, Boerhaave): dor torácica intensa após vômitos/procedimento, enfisema subcutâneo, pneumomediastino, derrame; evolui rápido para sepsis
- MEDIASTINITE NECROSANTE DESCENDENTE: origem odontogênica/amigdalar -> edema cervical, odinofagia, trismo, febre + dor torácica/dispneia
- Trauma penetrante / pós-procedimentos (cateteres, cirurgias cervicais)

PERGUNTAS-CHAVE / RED FLAGS

ALTA SUSPEIÇÃO

- Esternotomia/cirurgia cardíaca nas últimas semanas? Secreção/instabilidade na ferida esternal?
- Endoscopia/dilatação/IOT difícil ou corpo estranho? Vômitos fortes seguidos de dor torácica súbita (Boerhaave)?
- Dor de garganta/infecção dentária antes de piorar? (mediastinite descendente)
- CREPITAÇÃO no pescoço/peito (enfisema subcutâneo); dor retroesternal; disfagia/odinofagia; rouquidão
- Sinais de SEPSE: calafrios, confusão, hipotensão, extremidades frias, lactato elevado

AValiação e Exames

TC É O EXAME PRINCIPAL

- Exame físico: ABCDE + sinais de sepse; pescoço (edema, trismo, crepitação); tórax (dor retroesternal, MV reduzido); ferida esternal (hiperemia, drenagem, deiscência, instabilidade)
- TC de TÓRAX com contraste IV é o principal exame do mediastino
- Suspeita de mediastinite descendente: TC de PESCOÇO + tórax
- Suspeita de perfuração esofágica: esofagografia com contraste hidrossolúvel ± TC contrastada
- Labs: hemograma, eletrólitos, função renal/hepática, PCR, gaso/lactato se sepse; HEMOCULTURAS (2 pares) antes do ATB se não atrasar; ECG se dor torácica

Antibiótico Empírico por Etiologia

Rx AMPLO ESPECTRO IMEDIATO

PÓS-ESTERNOTOMIA (cobrir MRSA + Gram-negativo + anaeróbio): Piperacilina-tazobactam + Vancomicina; ou Cefepime + Metronidazol + Vancomicina
PERFURAÇÃO ESOFÁGICA (Gram-negativo/anaeróbio ± fungo se grave): Piperacilina-tazobactam ou Cefepime + Metronidazol
DESCENDENTE (orofaríngea/odontogênica): Ceftriaxona + Metronidazol (ampliar conforme gravidade)
Doses: Pipe-tazo 4,5 g EV 6/6h; Cefepime 2 g EV 8-12/12h; Metronidazol 500 mg EV 8/8h; Vancomicina 15-20 mg/kg EV 8-12/12h
Colher culturas antes SE não atrasar; ajustar conforme antibiograma; em choque, considerar ampliar

SupORTE e ContROLE de Fonte

Rx MEDIDAS NO PS

Monitorização contínua, 2 acessos calibrosos, O2 para meta; cristalóide se hipoperfusão (protocolo de sepse)
JEJUM (especialmente se suspeita de perfuração esofágica); analgesia (a dor piora a ventilação); antiemético se náusea
CONTROLE DE FONTE urgente é determinante: acionar cirurgia torácica (± cirurgia geral, otorrino/cabeça-pescoço se foco cervical, endoscopia, UTI, infectologia)
Acionar a cirurgia IMEDIATAMENTE se instável, sinais de perfuração/coleção importante ou deterioração rápida
Analgesia: Dipirona 1 g EV 6-8/8h ou Paracetamol 1 g 8/8h; opioide titulado se dor intensa

INTERNAÇÃO / UTI

DESTINO

- ☐ Suspeita de mediastinite aguda = INTERNAÇÃO (praticamente sempre)
- ☐ UTI quase sempre: instabilidade, lactato elevado, necessidade de O2 alto fluxo/VM, rebaixamento, progressão rápida, coleções na TC, perfuração esofágica, pós-esternotomia com sinais locais importantes
- ☐ Alta do PS em geral NÃO se aplica — só se mediastinite foi DESCARTADA por avaliação/imagem e há diagnóstico alternativo definido
- ☐ Acionamento multidisciplinar precoce muda o prognóstico
- ☐ Manter jejum e suporte de sepse durante a espera/transferência

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos; suspeita de mediastinite (etiologia: esternotomia/perfuração esofágica/foco cervical).
- História típica ____; ferida esternal (drenagem/instabilidade) ____; crepitação cervical/torácica ____; sinais de sepse ____ (lactato ____).
- TC ____ (coleção/ar/pneumomediastino?); hemoculturas ____; ATB ____ iniciado às ____; jejum + volume.
- Solicito UTI + cirurgia torácica ($\pm$ cabeça-pescoço/endoscopia) para controle de fonte URGENTE; transporte com monitorização.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente no 14º dia de pós-esternotomia com febre, dor esternal, secreção na ferida e 'esternão instável'. Qual a principal hipótese e o exame?

- A) Pneumonia; radiografia simples
- B) Mediastinite pós-esternotomia; TC de tórax com contraste
- C) Pericardite; ecocardiograma apenas
- D) Infecção urinária; urocultura
- E) Costocondrite; observação

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual o exame de imagem principal na suspeita de mediastinite aguda?

- A) Radiografia de tórax isolada
- B) Tomografia de tórax com contraste IV ($\pm$ pescoço se suspeita descendente)
- C) Ultrassom abdominal
- D) Ressonância de crânio
- E) Cintilografia óssea

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Na mediastinite pós-esternotomia, o esquema antibiótico empírico deve OBRIGATORIAMENTE cobrir:

- A) Apenas Gram-positivos
- B) MRSA + Gram-negativos + anaeróbios (ex.: piperacilina-tazobactam + vancomicina)
- C) Apenas fungos
- D) Apenas anaeróbios
- E) Nenhum micro-organismo

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual é a origem típica da mediastinite necrosante descendente?

- A) Pós-esternotomia
- B) Infecção odontogênica/amigdalária cervical que desce pelos espaços profundos
- C) Pancreatite
- D) Litíase renal
- E) Diverticulite

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Além do antibiótico, qual medida é determinante para o prognóstico da mediastinite aguda?

- A) Repouso isolado
- B) Controle de fonte urgente (drenagem/cirurgia) com abordagem multidisciplinar
- C) Dieta hiperproteica
- D) Fisioterapia respiratória isolada
- E) Apenas analgesia

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Pós-esternotomia (7-30 dias) com febre, dor esternal, secreção e esterno instável é mediastinite até prova em contrário; a TC de tórax com contraste é o exame principal.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A TC de tórax com contraste IV é o exame principal do mediastino; acrescenta-se a TC de pescoço quando há suspeita de mediastinite descendente.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na mediastinite pós-esternotomia o esquema empírico deve cobrir MRSA + Gram-negativos + anaeróbios (ex.: piperacilina-tazobactam + vancomicina, ou cefepime + metronidazol + vancomicina).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A mediastinite necrosante descendente origina-se de infecção odontogênica/amigdaliana (orofaríngea) que desce pelos espaços cervicais profundos até o mediastino.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O controle de fonte urgente (drenagem/desbridamento cirúrgico) com abordagem multidisciplinar é determinante, junto ao antibiótico precoce e ao suporte de sepse.

SM24
Suporte ao Plantão Médico